

Obsupport.2 使用説明書

肥満症治療選択サポート - 医療従事者向け

公開 URL : <https://masao172.github.io/obsupport/>



東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
大平征宏

資料作成日：2026 年 9 月 7 日 / ツール最終更新日：2026 年 9 月 4 日

1. 目的と位置づけ

Obsupport.2 は、BMI、肥満関連健康障害、糖代謝、高血圧、脂質異常症、OSAS、MASH、事前治療の状況を入力し、日本国内の承認された効能・効果、最適使用推進ガイドライン、診療報酬上の基準等に照らし、治療選択肢の候補を整理する医療従事者向け判定補助ツールです。

本ツールは診断・処方・手術適応を自動決定するものではありません。最終判断は、医師が最新の添付文書、最適使用推進ガイドライン、保険通知、禁忌、併用薬、施設・医師要件、患者背景を確認した上で行ってください。

2. 象となる治療選択肢

治療選択肢	本ツールでの位置づけ
食事・運動・行動療法	すべての肥満症治療の基盤として表示します。
マンジャロ／オゼンピック	2 型糖尿病治療薬としての候補を整理します。肥満症適応としての判定ではありません。
ウゴービ（肥満症）	BMI・肥満関連健康障害・関連疾患・事前治療等から主要要件を整理します。
ゼップバウンド（肥満症）	BMI・肥満関連健康障害・関連疾患・事前治療等から主要要件を整理します。耐糖能異常のみのケースは別表示します。
ゼップバウンド（OSAS）	OSAS 独立適応の患者選択条件を別に判定します。
ウゴービ（MASH）	MASH 独立適応の主要条件を別に判定します。
腹腔鏡下スリーブ状胃切除術	BMI、対象合併症、内科的治療歴等から保険算定基準上の候補を整理します。
腹腔鏡下スリーブ・バイパス術	BMI、2 型糖尿病、内科的治療歴等から主要条件を整理します。

3. 基本的な使い方

1. 身長・体重を入力する

BMI が自動計算されます。BMI は小数第 2 位以下を切り捨て、小数 1 位で表示・判定します。四捨五入による基準値への繰り上げは行いません。

2. 糖尿病・耐糖能・高血圧・脂質異常症を入力する

2 型糖尿病の有無、HbA1c、薬物療法の有無、耐糖能異常、高血圧、脂質異常症を入力します。

3. 肥満に関連する健康障害を選ぶ

高尿酸血症・痛風、冠動脈疾患、脳梗塞/TIA、脂肪性肝疾患、月経異常・女性不妊、運動器疾患、肥満関連腎臓病等を選択します。OSAS は専用欄の入力結果から自動的にカウントされます。

4. 事前治療を確認する

食事・運動療法、肥満症薬物療法に必要な投与施設での事前治療、手術に必要な内科的治療歴を入力します。

5. OSAS と MASH を必要に応じて入力する

OSAS 独立適応、MASH 独立適応を判定する場合は専用欄を入力します。OSAS は肥満関連健康障害・手術合併症のカウントにも反映されます。MASH「あり」は脂肪性肝疾患にも連動します。

6. 「治療選択肢を判定」を押す

治療ごとに「候補」「主要要件未充足」「入力が必要」等が表示されます。画面の要点と根拠表示を確認してください。

7. 必要に応じて投与期間を計算する

製剤・適応と開始日を選ぶと、最大投与期間のある製剤は上限到達日、MASH は再評価目安日等を表示します。

4. 入力項目の明

4-1. BMI

身長（cm）と体重（kg）から自動計算します。表示・判定は小数第2位以下を切り捨てて小数1位としています。これは四捨五入だけで27、32、35などの基準値に繰り上がることを避けるための本ツール上の保守的運用です。

4-2. 糖尿病・耐糖能・高血圧・脂質異常症

2型糖尿病は有無と薬物療法の有無を分けて入力します。高血圧・脂質異常症も、診断の有無だけでなく薬物療法の有無を選択します。耐糖能異常については、ゼップバウンド肥満症適応の追加条件確認に用いる空腹時血糖、75gOGTT 2時間値、HbA1c等を入力できます。

4-3. 肥満関連健康障害

該当する健康障害を選択すると、糖代謝異常、高血圧、脂質異常症、OSAS等と合わせて健康障害数を自動集計します。脂肪性肝疾患はNAFLD/MASLD等の臨床診断を想定しています。MASH独立適応の判定は別欄で行います。

4-4. OSAS

OSASを「あり」とした場合、睡眠検査の種類とAHI/REIの入力が必須です。

本ツールでは、AHI/REI 15以上は症状の有無にかかわらずOSASとしてカウントし、5以上15未満ではOSAS関連症状「あり」の確認を必須とします。5未満、または5以上15未満で症状なしの場合は、肥満関連健康障害・手術合併症としてカウントせず、診断内容の確認を促します。

CPAP/PAP 治療中でも OSAS 診断が継続していれば「あり」として扱えます。ゼップバウンドの OSAS 独立適応判定では、処方検討時の PSG/OCST による AHI/REI を入力し、CPAP 機器に表示される治療中の残存 AHI は判定値として使用しません。独立適応の指数条件は、PSG AHI 15 以上または OCST REI 30 以上を別に確認します。

4-5. MASH

MASH「あり」を選択すると、肥満関連健康障害の脂肪性肝疾患にも連動して反映されます。MASH を「なし」または「未評価」に戻すと、MASH による自動チェックは解除されます。ウゴービの MASH 独立適応については、肝硬変の有無、F2/F3、肝生検または NIT+専門医総合判断等を入力して判定します。

5. 判定結果の見方

表示例	意味
候補 / 最適使用 GL 上の候補	入力された主要条件が基準上の候補に合致しています。最終判断には禁忌、併用薬、施設・医師要件等の確認が必要です。
現時点で主要要件未充足	入力された範囲では必要条件の一部が不足しています。要点欄に不足・未確認項目が表示されます。
入力が必要	判定に必要な項目が不足しています。OSAS の検査値や症状確認等を入力してください。
未判定（未評価）	対象疾患が未評価のため、独立適応について判定していません。
対象外 / 適応なし	入力内容から、その適応に該当しないと整理されます。

判定結果が「候補」であっても、処方可能・手術適応確定を意味しません。特にウゴービ・ゼップバウンドは適応ごとの施設要件・医師要件があります。

6. 注射製の投期間計算

製剤・適応と使用開始日を入力すると、投与上限到達日または再評価目安日を表示します。最大投与期間のある週 1 回製剤は、開始日から「最大〇週間」の上限到達日を計算します。実際の最終投与日は、投与曜日、中止計画、休薬等により調整してください。

製剤・適応	ツール上の期間表示
ウゴービ（肥満症）	最大 68 週間の上限到達日を表示
ゼップバウンド（肥満症）	最大 72 週間の上限到達日を表示
ゼップバウンド（OSAS）	最大 52 週間の上限到達日を表示

製剤・適応	ツール上の期間表示
ウゴービ（MASH）	固定上限ではなく、開始約 12 か月後の再評価目安日を表示
マンジャロ／オゼンピック（2 型糖尿病）	本ツールでは固定上限なしとして扱う

7. プライバシーとオフライン動作

入力された身長・体重・検査値・合併症等は、判定のために端末内のメモリ上で一時的に処理されます。本ツール自体には、入力内容を端末・ブラウザ保存領域やファイルへ保存したり、外部サーバーへ送信したりする機能はありません。ページを閉じる、またはリセットすると、入力内容を再利用する機能はありません。

判定機能は、初回読み込み後はインターネット接続なしでも使用できます。PMDA、厚生労働省等の原資料リンクを開くときだけ通信が必要です。

8. 利用上の重要な注意

- 本ツールは医療従事者向けです。
- 診断、処方、手術適応、保険請求の最終判断を自動化するものではありません。
- 添付文書・最適使用推進ガイドライン・診療報酬通知等は改訂されるため、原資料の最新版を確認してください。
- ウゴービ・ゼップバウンドは施設・医師要件を満たさない医療機関では実際に処方・投与できない場合があります。本ツールは施設要件そのものを判定しません。
- 患者個別の禁忌、併用薬、臓器機能、妊娠可能性、手術リスク等は別途評価が必要です。

9. バージョン・著作権・利用条件

名称：Obsupport.2（肥満症治療選択サポート）

ツール最終更新日：2026 年 9 月 4 日

著作権：© 2026 大平征宏

所属：東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

公開 URL：<https://masao172.github.io/obsupport/>

ツール本体は CC BY-NC-ND 4.0 で提供されています。適切なクレジット表示を条件に、非営利目的で内容を改変せずに複製・再配布できます。営利利用および改変したものの共有・配布には著作権者の許可が必要です。

10. 主な基準考資料

- **PMDA：ゼップバウンド添付文書**
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/530471_2499422G7022_1_05
- **PMDA：ゼップバウンド 最適使用推進ガイドライン（肥満症）**
<https://www.pmda.go.jp/files/000280607.pdf>

- **PMDA：ゼップバウンド 最適使用推進ガイドライン（OSAS）**
<https://www.pmda.go.jp/files/000280608.pdf>
- **PMDA：ウゴービ添付文書**
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/620023_2499418G5023_1_07
- **PMDA：ウゴービ 最適使用推進ガイドライン（肥満症）**
<https://www.pmda.go.jp/files/000281140.pdf>
- **PMDA：ウゴービ 最適使用推進ガイドライン（MASH）**
<https://www.pmda.go.jp/files/000281141.pdf>
- **厚生労働省：令和 8 年度 医科診療報酬点数表に関する事項（K656-2）**
<https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732089.pdf>

11. 短い使用手順

①身長・体重 → ②糖尿病/高血圧/脂質異常/健康障害 → ③事前治療 → ④必要に応じて OSAS/MASH
→ ⑤「治療選択肢を判定」 → ⑥結果の要点と根拠を確認 → ⑦必要に応じて投与期間を計算

本説明書は Obsupport.2 公開版の画面・ロジック（2026 年 9 月 4 日更新版）に基づいて作成しています。